

終末期・治療差し控えと意思決定 Home

 **共有ページ**(誰でもログイン不要):[クリックで開く](https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jc-1933a87172.html) / 下の枠でURLをワンクリックコピー

<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jc-1933a87172.html>

 **PDF**:[\[開く／ダウンロード\]\(https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jc-1933a87172.pdf\)](https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jc-1933a87172.pdf)



当院の標準(迷ったらこれ)

聖路加ICUでの実践

迷ったらこう動く

- 「Goals of Care」をDNARや人工呼吸の可否と同一視しない。**患者の価値観に基づき臨床的文脈のなかで定められる「医療の包括的な目標」**であって、個別の介入の可否リストではない(「Goals of Care」とは何か — 文献の合意に基づく操作的定義)
- DNAR指示が有効なのは心停止のときのみ。**心停止でない場面で侵襲的介入を行わないことではなく、そのためには改めて合意形成が要る**(日本救急医学会 高齢者救急に関する用語の統一概念 — DNAR指示が有効なのは心停止時のみ、「予想された急変」とフレイル2潮流(JJAAM2025))
- 緩和ケアは予後ではなく「必要性」に基づいて並行導入する。生存が見込まれる患者にも、延命治療と並行して症状・情報のやりとり・家族の負担を扱う(ICU緩和ケアの10のキーポイント — 緩和ケアは予後ではなく必要性に基づく(What's New枠・ICM2016))
- 予後スコアを治療制限の根拠にしない。**予後モデルに基づく治療縮小・中止の決定は、医療専門職の倫理的責任が禁じる**(無益な治療を避けることは尊厳と環境倫理の交点にある (Correspondence・ICM2023))
- 家族に「偽陽性はありません」と言わない。神経予後予測で「不良マーカー2つ以上なら偽陽性ゼロ」と報告されても、**良好転帰が33例しかない研究では「真の偽陽性率は95%の確からしさで10.6%以下」までしか保証されない**(rule of three: 0/n の上限は約 3/n)。原著自身の事前目標 $FPR < 10\%$ **すら統計的には満たしていない**。伝え方は「これまでの症例では外れたことがない」ではなく「10人に1人まで外れうる不確実性が残る」。判断は**第7日・第14日という時点を固定して(time-anchored)マーカーの持続を確認してから行う**(「偽陽性ゼロ」は本当にゼロか — 良好転帰33例では95%上限が10.6%、事前設定の10%を切れない(Matters Arising・CritCare2026))
- 意思決定能力(capacity)は診断名でも点数でも「医師の勧めに従うか」でもない。**選択を伝えられ・理解し・自分のこととして認識し・比較して考えられるか**の4過程を決定ごとに評価する(意思決定能力に関する10の誤解 — capacityは決定ごとの臨床判断、competencyは裁判所の法的判断 (VHA国家倫理委員会・JAMDA2004))
- 「困った家族」というラベルを貼る前に、**対立の層を見立てる**: 課題(何をすべきか) → プロセス(誰がどう決めたか) → 関係(信頼と敬意が壊れたか)。**関係領域に入ると解決は格段に難しくなる**(ICUの対立を課題・プロセス・関係の3層で読み解く — 「困った家族」の多くはプロセス不全の帰結(ナラティブレビュー・CritCare2026))

- 深刻な知らせは1回では伝わらない前提で設計する。**混乱・沈黙・怒り・無反応は「わかっていない家族」ではなく、扁桃体とコルチゾールが作業記憶と新規記録を止めている状態**(深刻な知らせを伝えるときの神経科学 — 扁桃体とコルチゾールが理解を奪う機序と5つの推奨(総説・ICM2026))。回復・書面・時間を置いた再確認を組む
- 多職種カンファでは医師の発話時間を意識的に減らす。フランスの実測では**実質14分のうち医師が94%を話し、看護師・看護助手は1分(5%)、心理士と学生は0分**(フランスICUの延命治療差し控え・中止カンファレンスの実態(Letter・ICM2022))
- 終末期の抗菌薬は「症状緩和になっているか」で判断する。死亡直前の40~80%に投与されているが、**症状緩和は21.4~56.7%と一貫せず、呼吸器感染では0~53%、尿路感染では60~92%と桁が違う**(終末期の抗菌薬は「必要悪」か — 死亡直前の40~80%に投与され症状緩和は21.4~56.7%(What's New・ICM2026))
- 決めきれないときは時間制限つき治療トライアル(TLT)を使う。5要素と家族面談の進め方を型として持つ(終末期における時間制限つき治療トライアル(TLT) — 5要素と家族面談の進め方(コメンタリー・JAMA2011))
- 家族体験を測るなら総合点ではなく領域別に残す。**15項目を1つの点数に丸めた瞬間に「どこを直せばよいか」が見えなくなる**(ICUにおける終末期ケアの家族体験を測定する重要性と課題(ICM編集))
- 蘇生をめぐる倫理的な行き詰まりを、個人の道徳的欠陥として扱わない。無益なCPR・slow code・moral distress は、法的曖昧さ・組織文化・チーム階層・資源制約が生み出す構造の産物として読む。当院で先に手を付けられるのは、DNAR記載様式でスコープ(心停止時のみか、心停止前の挿管・昇圧薬まで含むか)を明文化することと、蘇生後の構造化デブリーフィングを定型化すること(蘇生の倫理は個人の失敗ではなくシステムの産物 — 22研究から導かれた倫理的経路モデル(EPM・ナラティブレビュー・ResuscPlus2026))
- 人工呼吸の適応を判断するとき、生理学的な利益だけでなく「その人が世界とつながっている在り方」への影響も1項目として言語化する。高齢・終末期・慢性呼吸不全では特に。抜管後の数日に名前・身体・場所を言葉にして返す再方向づけも、著者らが挙げた具体策の1つ(人工呼吸を受けるという経験の存在論 — 機械論から全体論へ、生きられた身体と世界とのつながりを問う(From the Inside・ICM2026))
- 「無益な治療を続けている」という現場の痛みを、個人の耐性の問題として扱わない。ICU看護師のモラルディストレスの主因は組織要因4つ=**無益と感じる延命治療の実施・不要と思う検査処置の実施・患者対看護師比2:1超の人員不足・階層が発言を封じること**。したがって先に置くのはレジリエンス研修ではなく、①**難渋症例後48時間以内の ethics debriefing の定例化(15分・「正しいと思ったができなかったこと」を1人1つ)**、②**看護師が単独で倫理カンファを起票できる権限**、③**TLTの終了条件を開始時に書く運用**。個人のコーピングに頼らせると医師-看護師間の緊張へ「対立の付け

替え」が起きる。**ただしこの論文のプール値(MDS-R 49.98/MMD-HP 88.32)は引用しない**(SDをSEとして入力、Fig 2は13研究すべてで研究名と数値が取り違い、性差CIの符号が脱落)。使えるのは**質的統合の要因頻度分布と対処戦略リスト、そしてMMD-HP 27項目を質問票としてそのまま使えることだけ**(ICU看護師のモラルディストレス 34研究6461人 — プールMDS-R 49.98点・MMD-HP 88.32点、ただし統計処理に重大な疑義(SR・メタ解析・BMCNurs2026))

- ①のデブリーフィングは「予防」ではなく「緩和」にすぎない——起きてしまった苦痛を和らげるだけで、苦痛を生む構造(脱エスカレーションの手続き不在・階層)はそのまま残る。定例化は続けるが、②の起票権と③の終了条件の明記より先に置かない(当院の何がモラルディストレスを生んでいるか — 122人の面接が名指しした消費主義・医療階層・脱エスカレーションの構造不足(質的研究・JAMANetwOpen2025))
- モラルディストレスは「個人の脆さ」ではなく、病院が増幅した結果として扱う。4病院122人の面接が名指しした増悪因子は、①医療消費主義を受け入れる病院文化、②医療階層(看護師の排除だけでなく主科対専門科コンサルタントの力関係)、③脱エスカレーションを支える手続きの不在。核にあるのは「治療を足す手続きは豊富なのに、減らす手続きが無い」という構造的非対称である。したがって当院で先に手を付けるのは研修ではなく権限と手続きの変更：㊦看護師が主治医の同意なしに単独で倫理・緩和ケアコンサルを起票できる権限、㊧家族面談への看護師同席を監査してから必須化する(「30回の面談のうち看護師の同席は3回」という実測が上長を動かした)、㊨IC時に治療の終了条件を書面に明記する(TLTの5要素をそのまま使う)。前掲のメタ解析との使い分けは「測るのはメタ解析側(MMD-HP 27項目)、変えるのは本論文側(手続き)」(当院の何がモラルディストレスを生んでいるか — 122人の面接が名指しした消費主義・医療階層・脱エスカレーションの構造不足(質的研究・JAMANetwOpen2025))
- 「この人は決められない」「この人のQOLはどうせ低い」という無自覚の前提を点検する(ICUにおけるエイブリズム — 障害を理由に治療を絞っていないか(FROM THE INSIDE・ICM2023))

この領域の到達点

補足

Known / Unknown / What's new

- **確立したこと**: 欧州では治療制限が標準になった ([欧州ICUにおける終末期医療の変化 \(Ethicus-2, JAMA2019\)](#)): 16年で 68.3%→89.7%、制限なしの死亡は 31.7%→10.3%)。緩和ケアは予後ではなく必要性で。面会緩和はICUの既定にすべき (**SCCM 17ステートメント中、強い推奨はこれ1つだけ**)。
- **まだ決着していないこと**: ①ICU終末期の疼痛管理 (**質の高いエビデンスは存在せず、推奨の一致は「データの一致」ではなく「倫理原則と専門家の合意」に由来する**)、②緩和的抜管の手順 (**日本にプロトコルがない**)、③代理意思決定者の負担軽減、④文化差をまたぐ標準化。
- **最近変わったこと**: **対話そのものが研究対象になった**。対立の3層モデル、深刻な知らせの神経科学、カンファの発話時間の実測、[ICU toolbox — 家族面談の交渉スキル \(ICM2026\)](#) と、**「何を決めるか」から「どう話すか」へ重心が移っている**。もう一つは [医師をコーチングすると過剰治療患者のDNI-DNACPR記載が増える \(CODE段階的ウェッジRCT・ICM2024\)](#) で、**医師側への介入が記載行動を変えられることをRCTで示した**。
- **視点の移動**: 2026年には、蘇生の倫理を法・組織文化・チーム階層・個人の道徳的感受性という3層の相互作用として統合した概念モデル (Ethical Pathways Model) が提示された ([蘇生の倫理は個人の失敗ではなくシステムの産物 — 22研究から導かれた倫理的経路モデル \(EPM・ナラティブレビュー・ResuscPlus2026\)](#))。文献由来で前向き検証はされておらず、導入の根拠ではなく「自施設のどこが詰まっているか」を見る地図として使う。同じ年に、人工呼吸を受ける体験そのものを存在論の問題として立てた論説も出ており ([人工呼吸を受けるといふ経験の存在論 — 機械論から全体論へ、生きられた身体と世界とのつながりを問う \(From the Inside・ICM2026\)](#))、議論は「何を差し控えるか」から「その介入がその人に何をするか」へも広がりつつある。

Vault内で結論が割れている論点

論点	一方の立場	もう一方の立場	今どう扱うか
予後 予測 を治 療制 限に 使っ てよ いか	<u>早期WLSTを除外した心 停止後の神経予後予測 (不良マーカー2つ以上で 偽陽性ゼロ・ CritCare2026)</u> (不良マ ーカー2つ以上で偽陽性 ゼロ=多モデル予測は 妥当)	<u>「偽陽性ゼロ」は本当にゼロか — 良好転 帰33例では95%上限が10.6%、事前設 定の10%を切れない(Matters Arising・ CritCare2026)</u> (0/33はrule of threeで「10.6%以下」までの保証にす ぎず、事前目標FPR<10%を満たさない) ／無益な治療を避けることは尊厳と環境 倫理の交点にある(Correspondence・ ICM2023) (スコアは治療制限の根拠に ならない)	「予測」と「決定」を分け る。 予測は情報として家 族と共有し、決定は価値 観と合意形成で行う。 重 症度スコアを制限の理由 として記載しない。 「偽陽 性ゼロ」という言い方を 家族にも記録にも使わな い——観察されたゼロは 「稀」であって「ない」では ない
面会 緩和 は何 のた めか	<u>成人ICUの家族中心ケア SCCMガイドライン 2024 — 17ステートメ ント、強い推奨は面会緩 和の1つだけ (SCCM2024・ CCM2025)</u>	<u>柔軟な面会はせん妄を減らさないが家族 の不安・抑うつを改善する(ICU Visits ク ラスター交差RCT・JAMA2019)</u>	矛盾しない。患者のせん 妄を減らす施策としてで はなく、家族の不安・抑う つを減らす施策として位 置づける
終末 期に 抗菌 薬を 続け るか	<u>「症状緩和になる」という 臨床的直観</u>	<u>終末期の抗菌薬は「必要悪」か — 死亡直 前の40～80%に投与され症状緩和は 21.4～56.7%(What's New・ ICM2026)</u>	感染部位で分けて考え る。 尿路感染(60～ 92%)は緩和になりうる が、 呼吸器感染(0～ 53%)は根拠が薄い。 継 続の目的を毎回言語化す る

まずこの7本

- 1 「Goals of Care」とは何か — 文献の合意に基づく操作的定義 — 言葉の使い方を揃える1本
- 2 日本救急医学会 高齢者救急に関する用語の統一概念 — DNAR指示が有効なのは心停止時のみ、「予想された急変」とフレイル2潮流(JJAAM2025) — 日本の現場に直結

- 3 ICUの対立を課題・プロセス・関係の3層で読み解く — 「困った家族」の多くはプロセス不全の帰結(ナラティブレビュー・CritCare2026)
- 4 深刻な知らせを伝えるときの神経科学 — 扁桃体とコルチゾールが理解を奪う機序と5つの推奨(総説・ICM2026) — **面談設計が変わる**
- 5 意思決定能力に関する10の誤解 — capacityは決定ごとの臨床判断、competencyは裁判所の法的判断(VHA国家倫理委員会・JAMDA2004)
- 6 ICU緩和ケアの10のキーポイント — 緩和ケアは予後ではなく必要性に基づく(What's New枠・ICM2016)
- 7 フランスICUの延命治療差し控え・中止カンファレンスの実態(Letter・ICM2022) — **自施設のカンファを見直す鏡**

関連するトピックHome

-  心停止後ケアと神経予後予測 Home — 予後情報の扱い
-  フレイルと高齢重症患者 Home — 治療強度の決め方
-  Hotel ICU・人間的ケア Home — 家族の体験
-  AKIと腎代替療法の開始時期 Home — 高齢者の透析導入をどう話すか
-  HDU・SDU(中間治療室)と病床機能 Home — ICU入室の適応判断

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。